



SIMULADO INTEGRADORA - 2º PERÍODO

Baseado no padrão de cobrança da prova Integrada P2 2025.2 - questões inéditas, fechadas, com dificuldade elevada e pegadinhas conceituais.

Aluno:	_____
Turma:	_____ Data: ____/____/____
Instruções:	Assinale apenas uma alternativa correta em cada questão. Não há gabarito neste caderno.

1ª QUESTÃO

Módulo(s): IESC + SOI

Mulher de 69 anos, hipertensa, diabética e com obesidade grau I, procura a UPA pela terceira vez em dois meses por dor no joelho direito. A radiografia evidencia redução do espaço articular femorotibial medial, osteófitos marginais e esclerose subcondral. Após analgesia, a equipe discute como evitar que a paciente use a urgência como local regular de acompanhamento.

Considerando os achados anátomo-patológicos e a organização da Rede de Atenção à Saúde, assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) Artrite séptica; manter retorno semanal na UPA até desaparecerem os achados radiográficos, pois a urgência deve assumir o seguimento longitudinal.
- (B) Osteoartrite; realizar contrarreferência qualificada à APS, comunicando a agudização à equipe de Saúde da Família para reavaliar o plano terapêutico longitudinal.
- (C) Artrite reumatoide; encaminhar diretamente ao ambulatório de reumatologia, dispensando a APS por se tratar de doença crônica.
- (D) Lesão isolada de menisco; encaminhar para internação hospitalar, pois osteófitos e esclerose indicam instabilidade aguda grave.

2ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI + HAM

Homem de 64 anos, destro, apresenta início súbito de fraqueza predominante em membro inferior esquerdo, dificuldade de marcha e perda sensitiva no mesmo membro. Não há disfagia, ataxia

cerebelar ou alteração importante de linguagem. A imagem evidencia lesão isquêmica cortical no hemisfério direito, próximo à fissura longitudinal.

A correlação clínico-anatômica mais provável é:

Alternativas:

- (A) Comprometimento da artéria cerebral média direita, pois a região lateral do giro pré-central representa principalmente o membro inferior.
- (B) Comprometimento do sistema vertebro-basilar, pois a ausência de disfagia indica lesão restrita ao tronco encefálico.
- (C) Comprometimento da artéria cerebral anterior direita, afetando áreas motora e somestésica mediais relacionadas ao membro inferior contralateral.
- (D) Comprometimento da artéria cerebral posterior direita, afetando primariamente a cápsula interna e produzindo paresia isolada de membro inferior.

3ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Durante a leitura próxima, uma estudante percebe contração pupilar e aumento do poder refrativo do cristalino. O professor pergunta qual ação autonômica permite a acomodação para objetos próximos.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) A estimulação parassimpática contrai o músculo ciliar, reduz a tensão das fibras zonulares e torna o cristalino mais espesso.
- (B) A estimulação simpática contrai o músculo ciliar, aumenta a tensão das fibras zonulares e torna o cristalino mais espesso.
- (C) A estimulação parassimpática relaxa o músculo ciliar, tensiona os ligamentos suspensores e aumenta a curvatura do cristalino.
- (D) A midríase por contração do esfíncter da pupila é o principal mecanismo de foco para objetos próximos.

4ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Em aula sobre gametogênese masculina, o professor solicita que o aluno relacione corretamente células testiculares, hormônios e mudanças estruturais das espermatídes durante a espermiogênese.

A alternativa correta é:

Alternativas:

- (A) O FSH estimula as células de Leydig a secretarem testosterona, enquanto o LH atua diretamente nas espermatídes para formar o acrossomo.
- (B) A capacitação espermática ocorre dentro dos túbulos seminíferos e corresponde à compactação nuclear e formação da cauda flagelar.
- (C) A testosterona é produzida pelas células de Sertoli e age sobre as células de Leydig para liberar ABP e inibina.
- (D) O LH estimula as células de Leydig a produzirem testosterona, que sustenta a ação das células de Sertoli; na espermiogênese há compactação nuclear, formação do acrossomo e organização do flagelo.

5ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Paciente com suspeita de esclerose lateral amiotrófica apresenta sinais de comprometimento de neurônios motores superiores e inferiores. O residente revisa os tratos descendentes envolvidos no controle voluntário fino dos membros.

Sobre o trato corticoespinal lateral, é correto afirmar que:

Alternativas:

- (A) É uma via sensitiva ascendente responsável pela propriocepção consciente e pelo tato epicrítico.
- (B) Conduz comandos motores voluntários rápidos e hábeis, com grande importância para movimentos distais dos membros.
- (C) Regula exclusivamente funções autonômicas viscerais, como sudorese e motilidade intestinal.
- (D) Origina-se no cerebelo e controla principalmente a pressão arterial por reflexos bulbares.

6ª QUESTÃO**Módulo(s): HAM**

Homem de 35 anos chega após queda de escada. Ao exame, abre os olhos apenas à dor, responde verbalmente de forma confusa e localiza o estímulo doloroso com a mão. Sinais vitais estáveis.

A pontuação na Escala de Coma de Glasgow e a classificação são:

Alternativas:

- (A) 8 pontos, rebaixamento grave.
- (B) 9 pontos, rebaixamento grave.
- (C) 11 pontos, rebaixamento moderado.
- (D) 14 pontos, rebaixamento leve.

7ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI**

Uma paciente realiza dosagens seriadas de cortisol às 8h, 16h e 23h. O maior valor ocorre pela manhã, com queda progressiva ao longo do dia. Ela pergunta por que esse padrão se relaciona com energia, alerta e controle inflamatório.

A explicação mais adequada é:

Alternativas:

- (A) O cortisol é secretado de modo constante ao longo do dia, e pequenas variações laboratoriais não têm significado fisiológico.
- (B) O pico matinal decorre do ritmo circadiano do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, favorecendo gliconeogênese, mobilização energética e modulação anti-inflamatória.
- (C) A queda matinal do cortisol reduz a gliconeogênese e aumenta a sensibilidade periférica à insulina para facilitar o despertar.
- (D) O pico noturno do cortisol aumenta interleucinas pró-inflamatórias e prepara o organismo para o sono profundo.

8ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI**

Em corte histológico de pâncreas endócrino, observa-se lesão seletiva de células predominantes na região central das ilhotas. O paciente apresenta hiperglicemia persistente, perda ponderal e

necessidade de insulina exógena.

A correlação histofisiológica correta é:

Alternativas:

- (A) Lesão de células alfa, produtoras de insulina, causando hiperglicemia por falha na captação periférica de glicose.
- (B) Lesão de células delta, produtoras de glucagon, causando hiperglicemia por estímulo da glicogenólise.
- (C) Lesão de células PP, produtoras de somatostatina, causando diabetes mellitus tipo 1 por bloqueio da secreção exócrina.
- (D) Lesão de células beta, produtoras de insulina, reduzindo a captação tecidual de glicose e favorecendo hiperglicemia.

9ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Paciente em uso crônico de benzodiazepínico pergunta por que a medicação reduz ansiedade e excitabilidade neuronal. O professor explica que o fármaco potencializa a ação do GABA em receptor ionotrópico específico.

O mecanismo pós-sináptico mais compatível é:

Alternativas:

- (A) Abertura de canais de Na⁺, despolarizando a membrana e aproximando o neurônio do limiar.
- (B) Bloqueio permanente da repolarização, mantendo o axônio em condução contínua.
- (C) Aumento da abertura de canais de Cl⁻ via receptor GABAA, gerando hiperpolarização e redução da excitabilidade neuronal.
- (D) Fechamento de canais de K⁺, causando maior liberação de glutamato e facilitação do potencial de ação.

10ª QUESTÃO

Módulo(s): HAM + SOI

Atleta de arremesso apresenta dor no ombro e fraqueza para rotação interna. No exame, o médico solicita que ela coloque o dorso da mão na região lombar e tente afastá-lo do corpo contra resistência. O teste reproduz dor e perda de força.

O teste e o músculo avaliado são:

Alternativas:

- (A) Teste de Gerber; músculo subescapular.
- (B) Teste de Jobe; músculo infraespinal.
- (C) Teste de Patte; músculo subescapular.
- (D) Teste de Speed; músculo redondo menor.

11ª QUESTÃO

Módulo(s): HAM

Paciente refere escotoma central em olho esquerdo. O estudante precisa executar exame oftalmoneurológico básico de modo sistematizado para avaliar função visual, campos, motricidade ocular, reflexos pupilares e fundo de olho.

A sequência técnica mais adequada é:

Alternativas:

- (A) Iniciar pela fundoscopia, depois testar apenas a pupila do olho sintomático e finalizar com acuidade binocular.
- (B) Avaliar acuidade visual monocular, realizar campimetria de confrontação, testar movimentos oculares em H, avaliar reflexos fotomotores direto e consensual e concluir com fundoscopia em ambiente escurecido.
- (C) Avaliar simultaneamente acuidade visual e reflexo fotomotor, dispensando campimetria se a motricidade ocular estiver normal.
- (D) Realizar somente fundoscopia e movimentos oculares, pois escotoma central não altera acuidade visual nem campo visual.

12ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI**

Mulher de 45 anos apresenta cálcio sérico elevado, fósforo sérico baixo, nefrolitíase recorrente e PTH acima do valor de referência. O médico explica que a alteração hormonal produz efeitos ósseos, renais e intestinais.

Qual alternativa descreve corretamente o efeito do PTH nesse contexto?

Alternativas:

- (A) Aumenta a reabsorção óssea, aumenta a reabsorção renal de cálcio, reduz a reabsorção renal de fosfato e estimula a formação de calcitriol.
- (B) Inibe a reabsorção óssea, aumenta a excreção urinária de cálcio e reduz a absorção intestinal de cálcio.
- (C) Estimula a reabsorção renal de fosfato, justificando hipofosfatemia por depósito ósseo de cálcio.
- (D) Reduz a conversão renal de vitamina D ativa, bloqueando a absorção intestinal de cálcio.

13ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI**

Jogador de futebol sofre trauma rotacional no joelho, com edema, instabilidade e suspeita de lesão do ligamento cruzado anterior associada a lesão meniscal. Sobre a anatomia funcional do joelho, analise as assertivas:

- I. O ligamento cruzado anterior resiste ao deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur e contribui para limitar a hiperextensão.
- II. Os meniscos aumentam a congruência articular e ajudam a distribuir cargas entre fêmur e tíbia.
- III. Os meniscos ficam interpostos principalmente entre fêmur e patela, reduzindo impacto femoropatelar.
- IV. O joelho é uma articulação sinovial do tipo gínglimo modificado, podendo realizar pequena rotação quando flexionado.

É correto o que se afirma em:

Alternativas:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.

14ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Durante discussão sobre ovogênese, uma aluna afirma que a mulher renova continuamente suas ovogônias a cada ciclo menstrual. O professor corrige a afirmação e solicita a descrição correta dos bloqueios meióticos.

Assinale a alternativa correta.

Alternativas:

- (A) As ovogônias reiniciam mitoses mensais após a puberdade, mantendo a reserva ovariana até a menopausa.
- (B) Todos os ovócitos completam a meiose I antes do nascimento e permanecem em metáfase II até a puberdade.
- (C) O FSH completa diretamente a meiose II antes da ovulação, tornando o ovócito pronto para implantação.
- (D) O ovócito primário permanece em prófase I desde a vida fetal; o pico de LH permite a conclusão da meiose I, e a meiose II só se completa se ocorrer fecundação.

15ª QUESTÃO**Módulo(s): HAM**

Homem de 41 anos engasga com alimento, fica incapaz de falar, leva as mãos ao pescoço e apresenta cianose perioral. Após compressões abdominais, passa a emitir sons respiratórios audíveis, mas ainda respira com esforço e não consegue tossir eficazmente.

A interpretação e a conduta mais adequadas são:

Alternativas:

- (A) Houve desobstrução completa; suspender as manobras e liberar o paciente sem observação.
- (B) O sinal universal de engasgo indica inconsciência; iniciar RCP imediatamente, mesmo com pulso e responsividade.
- (C) Houve melhora parcial da obstrução; manter manobras de desobstrução até expulsão do corpo estranho ou recuperação de ventilação eficaz, e iniciar RCP se evoluir para inconsciência.
- (D) A presença de cianose indica obstrução parcial leve; observar passivamente e evitar qualquer intervenção.

16ª QUESTÃO**Módulo(s): HAM + IESC**

Durante visita domiciliar, a ACS orienta o cuidador de uma idosa diabética sobre glicemia capilar. Antes de demonstrar a técnica, pergunta como ele costuma medir, quais dificuldades encontra e o que já ouviu sobre hipoglicemia. Em seguida, demonstra higiene das mãos, punção lateral do dedo, descarte da lanceta e registro dos valores para discussão com a equipe.

A abordagem descrita caracteriza principalmente:

Alternativas:

- (A) Educação popular em saúde, pois parte da escuta do saber prévio, promove diálogo, prática compartilhada e corresponsabilização com a equipe.
- (B) Educação bancária, pois a técnica do glicosímetro sempre exige transmissão vertical sem participação do cuidador.
- (C) Ação exclusivamente técnica, sem relação com autonomia, pois o registro deve substituir a consulta médica.

(D) Transferência integral da responsabilidade do cuidado para a família, dispensando acompanhamento da APS.

17ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

Em laboratório de neurofisiologia, o professor estimula o tendão patelar e obtém extensão rápida da perna. Depois aplica estímulo doloroso no pé e observa retirada do membro estimulado associada à extensão do membro contralateral.

Sobre os arcos reflexos envolvidos, é correto afirmar que:

Alternativas:

- (A) O reflexo patelar é polissináptico, pois envolve vários interneurônios antes de ativar o quadríceps.
- (B) O reflexo de retirada é monossináptico, pois depende apenas de uma sinapse direta entre nociceptor e músculo flexor.
- (C) Ambos dependem exclusivamente da via piramidal e não ocorrem se o córtex motor estiver inativo.
- (D) O reflexo patelar é monossináptico, enquanto o reflexo de retirada é polissináptico e depende de interneurônios medulares.

18ª QUESTÃO

Módulo(s): SOI

A síntese de T3 e T4 envolve captação de iodeto, oxidação, organificação, acoplamento de iodotirosinas e liberação hormonal após endocitose da tireoglobulina iodada.

A alternativa que descreve corretamente esse processo é:

Alternativas:

- (A) As células parafoliculares captam iodeto por NIS e produzem T3 e T4 no coloide, enquanto células foliculares secretam calcitonina.
- (B) O iodeto é captado pelas células foliculares via NIS; a TPO oxida e organifica o iodo no coloide, formando MIT e DIT, que se acoplam; após endocitose e digestão lisossomal, T3 e T4 são liberados.
- (C) A tireoglobulina se liga ao iodeto no retículo endoplasmático, e a TPO atua dentro do lisossomo para formar T3 e T4 antes da secreção.
- (D) O acoplamento de MIT e DIT ocorre exclusivamente no citosol das células C, e a liberação hormonal independe de endocitose.

19ª QUESTÃO

Módulo(s): IESC

No território de uma ESF, surgem cinco casos suspeitos de dengue na mesma microárea. No mesmo dia, o médico realiza declaração de óbito de um idoso em cuidados paliativos. A equipe precisa registrar corretamente os eventos nos sistemas de informação em saúde.

Os formulários e sistemas correspondentes são:

Alternativas:

- (A) Declaração de Nascido Vivo no SINASC e Ficha de Procedimento no SISAB.
- (B) Ficha de Atendimento Individual no SISAB e Declaração de Nascido Vivo no SIM.
- (C) Ficha Individual de Notificação no SINAN e Declaração de Óbito no SIM.
- (D) Ficha de Vacinação no SI-PNI e Declaração de Óbito no SINASC.

20ª QUESTÃO**Módulo(s): SOI**

Paciente de 25 anos apresenta fadiga, ganho de peso, intolerância ao frio, redução da libido e testículos diminuídos. Exames mostram TSH, LH e FSH baixos, com cortisol basal preservado. O médico suspeita de falha seletiva na regulação hipotálamo-hipofisária dos eixos tireoidiano e gonadal.

A interpretação mais compatível é:

Alternativas:

- (A) Hiperprodução de TRH e GnRH pelo hipotálamo, elevando TSH, LH e FSH e causando hipogonadismo primário.
- (B) Deficiência de hormônios liberadores hipotalâmicos, como TRH e GnRH, reduzindo a secreção hipofisária de TSH, LH e FSH.
- (C) Falência primária das adrenais, pois cortisol normal indica excesso de ACTH e bloqueio das gonadotrofinas.
- (D) Hipersecreção hipofisária de TSH e LH, com feedback negativo sobre tireoide e testículos.